

TEMA 10.27 • REUMATOLOGÍA

Poliarteritis Nodosa

PERFIL EUNACOM 1.06.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Poliarteritis Nodosa (PAN)** es una vasculitis sistémica que afecta primariamente a los **vasos de mediano calibre**, aunque en ocasiones puede comprometer vasos pequeños. Se caracteriza por una inflamación necrotizante de las arterias musculares que puede llevar a la formación de microaneurismas, estenosis e infartos orgánicos.

Etiología y Asociaciones

La causa exacta de la PAN es desconocida en la mayoría de los casos (aproximadamente el 80%), atribuyéndose a mecanismos inmunitarios no aclarados o reacciones a infecciones previas. Sin embargo, existe una asociación clásica que es de alto rendimiento para el examen:

- **Virus de la Hepatitis B (VHB):** Cerca del 20% de los casos de PAN se asocian a una infección activa por VHB.
- **Virus de la Hepatitis C (VHC):** Se asocia en un porcentaje menor que el VHB.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante un paciente con clínica de vasculitis de vaso mediano, siempre se debe solicitar serología para **Hepatitis B**, ya que el tratamiento de la infección viral es parte fundamental del manejo en esos casos.

Cuadro Clínico

La PAN es una enfermedad multisistémica. Sus manifestaciones dependen de qué arterias específicas estén siendo afectadas por la inflamación.

1. Manifestaciones Cutáneas

Son muy frecuentes y suelen ser el primer signo de sospecha: - **Púrpura palpable:** Generalmente en extremidades inferiores. Puede presentarse como petequias o pápulas violáceas (similar a la **Púrpura de Schonlein-Henoch**). - **Livedo reticularis:** Un patrón vascular violáceo en red o "dibujo de vasos" en la piel, muy característico de la afectación de vasos medianos. - **Úlceras cutáneas:** Secundarias a la isquemia de los tejidos.

2. Compromiso Renal

A diferencia de otras vasculitis, la PAN tiene una forma particular de afectar el riñón: - **Infartos renales:** La inflamación de las arterias renales principales o segmentarias provoca áreas de isquemia. - **Hipertensión arterial (HTA):** Suele ser de tipo **renovascular** o similar, debido a la isquemia renal que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Pregunta frecuente de examen: La PAN clásica **NO produce glomerulonefritis**. Si el paciente presenta sedimento urinario con hematuria dismórfica o cilindros hemáticos (signos de daño glomerular), lo más probable es que se trate de una **Poliangeítis Microscópica (PAM)** y no de una PAN.

3. Compromiso Neurológico

- **Mononeuritis múltiple:** Es la afectación de dos o más nervios periféricos no contiguos (por ejemplo, caída del pie y debilidad en una mano). Esto ocurre por isquemia de los *vasa nervorum*. Aunque es típica de vasos pequeños, la PAN la presenta con frecuencia.

4. Compromiso Gastrointestinal

- **Dolor abdominal:** Muy frecuente tras la ingesta (angina abdominal). - **Isquemia mesentérica:** Puede llegar a producir infarto intestinal o perforación debido al compromiso de las arterias mesentéricas (vasos medianos).

Diagnóstico y Laboratorio

El diagnóstico de la PAN es un desafío clínico y se apoya en los siguientes pilares:

Marcadores Inmunológicos (ANCA)

- La PAN clásica es predominantemente **ANCA negativa**. - Si un paciente presenta un cuadro sugerente pero resulta **ANCA positivo** (especialmente p-ANCA/anti-MPO), se debe sospechar fuertemente una **Poliangeítis Microscópica**.

Estudios de Imagen y Biopsia

1. **Biopsia:** Es el estándar de oro. Se busca obtener tejido de un órgano afectado (piel, nervio o músculo) donde se observe inflamación necrotizante de arterias de mediano o pequeño calibre sin afectación de vénulas. 2. **Angiografía:** En casos donde la biopsia no es factible (como compromiso abdominal o renal), se realiza una angiografía (convencional o angio-TAC) buscando **microaneurismas** (aspecto en "rosario" o "cuenta de collares") y zonas de estenosis.

TABLA 10.27.1: CARACTERÍSTICA VS POLIARTERITIS NODOSA (PAN)

CARACTERÍSTICA	POLIARTERITIS NODOSA (PAN)	POLIANGEÍTIS MICROSCÓPICA (PAM)
Tamaño de vaso	Mediano (principalmente)	Pequeño
ANCA	Generalmente Negativo	Positivo (p-ANCA / anti-MPO)
Glomerulonefritis	Ausente	Presente (frecuente)
Capilaritis Pulmonar	Ausente	Presente (hemorragia alveolar)
Asociación VHB	Sí (20%)	No

Manejo y Tratamiento

El tratamiento busca frenar la respuesta inflamatoria agresiva para evitar daños orgánicos irreversibles.

- **Casos Leves/Moderados:** Se utilizan **corticoides** (Prednisona) asociados a ahorradores de corticoides (como Azatioprina o Metotrexato).
- **Casos Graves (Compromiso de órgano vital):**
 - Dosis altas de corticoides (pulsos de metilprednisolona).
 - Inmunosupresores potentes: **Ciclofosfamida** o **Rituximab**.
- **Casos asociados a VHB:** Además del manejo de la vasculitis, se requiere tratamiento antiviral específico y, en ocasiones, plasmaféresis.

NOTA CLÍNICA

La patogenia de la PAN implica el depósito de inmunocomplejos en la pared arterial, lo que desencadena una infiltración de polimorfonucleares y necrosis fibrinoide. Esto debilita la pared (formando aneurismas) o la ocluye (causando infartos).

Perlas EUNACOM

- **PAN = Vaso Mediano.** - **PAN = No hay Glomerulonefritis.** - **PAN = ANCA Negativo.** - **PAN = Asociación con Hepatitis B.** - Si te describen un paciente con **HTA de reciente comienzo, dolor abdominal y livedo reticularis**, piensa primero en PAN.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente con púrpura palpable en extremidades inferiores, dolor abdominal e hipertensión arterial. Los ANCA son negativos y no hay glomerulonefritis. Tiene antecedente de hepatitis B. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Poliarteritis Nodosa. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Vasculitis de vaso mediano; 20% asociada a hepatitis B
- Clínica: púrpura vasculítico, livedo reticularis, úlceras en piernas, infartos renales (no glomerulonefritis), mononeuritis múltiple, isquemia mesentérica
- ANCA negativa: si ANCA positivo o glomerulonefritis, sospechar poliangeítis microscópica
- Afectación renal por infartos (no glomerulonefritis) con hipertensión renovascular
- Diagnóstico: biopsia de arterias comprometidas o angiografía
- Tratamiento: corticoides + ahorradores; casos graves con ciclofosfamida o rituximab

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (POLIARTERITIS NODOSA)**PREGUNTA 1**

Paciente con púrpura palpable en extremidades inferiores, dolor abdominal e hipertensión arterial. Los ANCA son negativos y no hay glomerulonefritis. Tiene antecedente de hepatitis B. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Granulomatosis de Wegener
- B)** Poliangeítis microscópica
- C)** Poliarteritis nodosa
- D)** Púrpura de Schönlein-Henoch
- E)** Churg-Strauss

PREGUNTA 2

¿Qué diferencia la afectación renal de la poliarteritis nodosa de la de las vasculitis ANCA positivo?

- A)** La PAN causa glomerulonefritis y las ANCA positivo no
- B)** La PAN causa infartos renales y las ANCA positivo causan glomerulonefritis
- C)** No hay diferencia
- D)** La PAN no afecta los riñones
- E)** Las ANCA positivo causan infartos y la PAN glomerulonefritis

PREGUNTA 3

Si un paciente con sospecha de poliarteritis nodosa presenta ANCA positivo, ¿qué debe sospecharse?

- A)** PAN con marcador atípico
- B)** Que en verdad es una poliangeítis microscópica
- C)** Lupus eritematoso sistémico
- D)** Arteritis de Takayasu
- E)** Enfermedad de Kawasaki

RESUMEN: POLIARTERITIS NODOSA

La poliarteritis nodosa (PAN) es una vasculitis de vaso mediano que en un 20% de los casos se asocia a infección por virus hepatitis B (y en menor porcentaje hepatitis C), siendo el 80% restante de causa desconocida. Su clínica incluye púrpura vasculítico palpable de extremidades inferiores, úlceras en piernas, livedo reticularis, afectación renal por infartos renales (no glomerulonefritis) con hipertensión renovascular, mononeuritis múltiple, y dolor abdominal con posible isquemia mesentérica. Es ANCA negativa, lo cual es un dato clave: si sale ANCA positivo o tiene glomerulonefritis, se sospecha poliangeítis microscópica en vez de PAN. El diagnóstico se hace con biopsia de arterias comprometidas o angiografía que muestre la afectación. El tratamiento es con corticoides más ahorradores de corticoides, y en casos graves se maneja como vasculitis ANCA positivo con ciclofosfamida o rituximab.